

DSA Parte 2 e Polyhandicap

Percorsi nelle Disabilità · Sessione 09 · 21 aprile 2026

Lezione doppia: si parte dalla seconda parte sull'autismo — aspetti professionali, approcci e risorse sul territorio — e si chiude con una nuova utenza, quella del polyhandicap. Due mondi diversi, ma entrambi richiedono la stessa cosa: preparazione, pazienza e rispetto per chi non può parlare ma comunica eccome.

Parte 1 — ASD: aspetti professionali

Il punto di partenza: la persona, non la diagnosi

La prof apre con una citazione potente di [Villa e Vivanti \(2007\)](#), che descrive il mondo vissuto dalla prospettiva di una persona con disturbo dello spettro autistico ([ASD — Autism Spectrum Disorder](#)):

"Un mondo in cui la gente ci parla continuamente come se capissimo e invece non capiamo, in cui non sappiamo mai cosa sta per succedere, in cui le cose accadono in modo caotico, senza un ordine, senza prevedibilità, in cui la nostra attenzione è catturata da oggetti che ruotano, nell'acqua che scorre o da un ventilatore anziché dallo sguardo delle persone, dove la voce di chi parla può trasformarsi in un rumore assordante e la consistenza dei vestiti può essere una tortura per la pelle..."

Un paragrafo da tenere sempre in testa — condensa ipersensibilità sensoriale, difficoltà comunicative e imprevedibilità dell'ambiente sociale in quattro righe. È il primo passo per lavorare bene.

Un concetto fondamentale ribadito rispetto alla lezione precedente: **le persone con ASD non guariscono, ma si educano**. La diagnosi medica (livello 1, 2 o 3) non è il fulcro del lavoro educativo. Quello che conta è la **diagnosi funzionale** (o

analisi funzionale): capire *come* quella persona specifica funziona nel suo contesto quotidiano.

Come diceva la prof, **sapere che Mario alle 10 di mattina riesce a fare X ma non Y in quell'ambiente specifico ti dà molto più di sapere che ha un ASD di livello 2.**

L'analisi funzionale

L'**analisi funzionale** osserva e descrive il funzionamento della persona nelle diverse aree della vita. Tiene in considerazione:

- L'insieme delle **disabilità e difficoltà** (legate alla menomazione o al contesto sociale)
- Il quadro generale delle **capacità** (con attenzione ai residui funzionali e alla recuperabilità)
- Le **potenzialità di sviluppo**: il punto su cui si costruisce l'intervento educativo

È qui che si lavora. Non si parte da zero, si parte da dove la persona è — la famosa zona di sviluppo prossimale.

Le aree di lavoro dell'educatore

Il **PEI (Piano Educativo Individualizzato)** si costruisce intorno a cinque aree principali:

Area	Note
Abilità motorie	Spesso trascurate, ma fondamentali. L'apprendimento parte dal corpo.
Autonomie personali	Allacciarsi le scarpe, mangiare da soli: tutto dipende dalla motricità fine e dallo sviluppo corporeo.
Apprendimenti scolastici	Aspetto importante nel progetto di vita.
Abilità sociali	

Area	Note
	Area più critica; comprende abilità strumentali e relazionali.
Comunicazione	Area fondamentale, su cui si ritorna più volte nella lezione.

Abilità vs. Competenze sociali

Importante distinguere due concetti che sembrano simili ma non lo sono:

- **Abilità sociali** (Castaldo et al., 2021): comportamenti specifici appresi per interagire efficacemente. Si dividono in:
 - *Abilità strumentali*: usare strumenti per generare reciprocità (es. il linguaggio)
 - *Abilità relazionali*: interpretare emozioni, adattarsi ai diversi contesti di vita
- **Competenze sociali** (Keller, 2021): concetto più ampio — "il possesso di capacità complesse derivanti non solo dalla somma delle singole abilità sociali, ma comprendenti la capacità di esperire e gestire le relazioni sociali attraverso la padronanza di significati, vissuti e relazioni emotive, e lo sviluppo delle funzioni metacognitive".

Pensala come le piante: l'abilità è il seme — specifico, singolo. La competenza è l'albero adulto — radici, tronco, rami, adattato al suo ambiente. Le persone con ASD possono avere il seme, ma sviluppare l'albero richiede un lavoro enorme.

I fattori che ostacolano lo sviluppo delle competenze sociali nelle persone con ASD sono tre: 1. **Fattori neurobiologici**: deficit nelle funzioni metacognitive 2. **Comorbidità psichiatriche**: ansia e depressione (molto frequenti negli adulti con ASD) 3. **Mancanza di motivazione**: spesso causata da ripetuti fallimenti socializzanti — hanno provato, è andata male, si sono ritirati

Lavorare sulla comunicazione

È il cuore del lavoro educativo. Si parte sempre dai **prerequisiti della comunicazione**, cioè le fondamenta senza cui nessuno strumento — nemmeno il migliore tablet con sintesi vocale — può funzionare:

Prerequisito	Spiegazione
Percezione sensoriale	Ascoltare, osservare espressioni e gesti. La base assoluta.
Interazione sociale	Trovare interesse per l'altro e per il mondo circostante.
Imitazione	I bambini imparano per imitazione; nelle persone con ASD è una difficoltà importante.
Gestualità	I gesti precedono il linguaggio verbale — indicare, tendere le mani.
Attenzione condivisa	Focalizzarsi sullo stesso oggetto/evento insieme a un'altra persona.
Intento comunicativo	Voler comunicare — non è scontato, va sviluppato.
Sviluppo cognitivo	Riconoscimento di pattern, memoria, associazione di idee.

L'**attenzione condivisa** merita un focus speciale. Significa che due persone guardano insieme la stessa cosa — tipo due giocatori che seguono il pallone. Sembra banale, ma per alcune persone con ASD è un obiettivo enorme. Senza attenzione condivisa non si costruisce niente sopra: non l'imitazione, non il linguaggio, non il gioco condiviso.

Quando la comunicazione verbale non è possibile o non è ancora raggiunta, si usano sistemi di **CAA (Comunicazione Aumentativa e Alternativa)**: pittogrammi, immagini, gesti, oggetti concreti. Uno dei sistemi più noti è il **PECS (Picture Exchange Communication System)**.

Michael Halliday (1975-1980) ha individuato **7 funzioni linguistiche** che i bambini sviluppano nell'apprendimento del linguaggio — tutte vanno lavorate anche con le persone con ASD: 1. Strumentale — "Voglio" 2. Regolatoria — "Fallo" 3. Interazionale — "Ciao" 4. Personale — "Mi piace" 5. Euritmica — filastrocche, giochi linguistici 6. Referenziale — "È rosso" 7. Immaginativa — storie inventate

Come si lavora: caratteristiche degli approcci

Gli approcci per le persone con ASD si distinguono da altri interventi educativi per tre caratteristiche:

1. **Spazi quotidiani e ripetuti (training)**: non basta farlo una volta a settimana. Va fatto tutti i giorni, più volte al giorno, da *tutte* le persone che lavorano con quella persona — scuola, casa, istituto, tutti allineati.
2. **Metodologia direttiva e strutturata**: l'educatore non improvvisa. Pianifica, anticipa, struttura il tempo e lo spazio.
3. **Rete allargata**: non solo professionisti tecnici — i genitori sono parte centrale dell'intervento.

La **strutturazione del tempo** è fondamentale. **Una persona con ASD che non sa cosa succederà tra 10 minuti vive in uno stato di ansia perenne. Aggiungere prevedibilità all'ambiente abbassa l'ansia. E abbassare l'ansia è il primo obiettivo — senza quello, nessun training funziona.**

Il prof sottolinea: *"La prima cosa da fare è abbassare il livello d'ansia e fargli star bene. Dopo che hai raggiunto questo obiettivo, puoi iniziare a insegnare qualcosa di nuovo."*

Questo vale anche per i supporti visivi: programma giornaliero, timer, pittogrammi. **Non per tutti la stessa soluzione — c'è chi capisce la parola, chi ha bisogno della fotografia, chi ha bisogno dell'oggetto fisico (lo zaino con il costume è più comprensibile della foto della piscina, che è più comprensibile della parola "piscina").**

I comportamenti problema

I comportamenti problema non vanno soppressi — vanno compresi.

L'approccio educativo li tratta come comportamenti con una funzione comunicativa: la persona sta cercando di dire qualcosa, ma non ha gli strumenti per dirlo in modo socialmente accettabile.

Si effettuano **valutazioni funzionali** per capire la struttura e la funzione del comportamento, e poi si insegna un comportamento alternativo con la stessa funzione.

Esempio dalla lezione: una ragazza con polyhandicap lanciava il piatto quando c'erano i pomodori nell'insalata. Per chi non la conosceva sembrava un "problema di comportamento". Per chi la conosceva era chiaramente un "problema di comunicazione" — non aveva strumenti per dire "togli i pomodori". La soluzione non era punirla, ma trovare un canale alternativo per esprimere il rifiuto.

La motivazione come leva

Uno dei principi più importanti: **la motivazione della persona va messa al centro**. Non si parte da ciò che l'educatore vuole insegnare, ma da ciò che interessa alla persona.

Esempio citato dalla prof: un operatore che accompagnava un ragazzo a giocare a Dungeons & Dragons con i dadi stava in realtà sviluppando abilità sociali, di lettura del contesto, di gestione delle regole — tutto costruito attorno a qualcosa che al ragazzo piaceva moltissimo. Non è scoprire l'acqua calda — è semplicemente buon senso educativo.

I principi guida dell'intervento (in sintesi)

Le slide elencano 11 principi fondamentali:

1. Diagnosi precoce
2. Obiettivi individualizzati su comunicazione, socializzazione e comportamento adattivo

3. Collaborazione genitori-professionisti e valutazioni periodiche del PEI (progetto di vita)
4. Insegnamento individualizzato, strutturato, "massiccio" e da parte di tutti
5. Adattamento dell'ambiente
6. Sviluppo delle potenzialità (punti di forza)
7. Applicazione di diversi metodi e approcci
8. Servizi coordinati per l'intero ciclo di vita
9. Conoscenza aggiornata delle peculiarità dell'autismo
10. Conoscenza delle risorse e organizzazioni con esperienza
11. Formazione e scelta del personale

I principali approcci e metodi

Approccio	Autori / Anno	Caratteristiche principali
ABA (Analisi Applicata del Comportamento)	Skinner (1904-1990)	Studia la relazione comportamento-ambiente. Setting 1:1, rinforzo positivo.
Approcci Naturalistici	Koegel et al. (1979)	Basati sull'ABA ma in contesti spontanei; seguono l'iniziativa del bambino.
CBT (Terapia Cognitivo-Comportamentale)	Ellis e Beck, anni '60	Lavora su pensieri, emozioni e comportamenti disfunzionali.
Interventi abilitativi (training)	Moderato	Procedure su abilità specifiche; partono da bilancio funzionale.
CAA	—	Sistemi simbolici alternativi al verbale (pittogrammi, PECS...).
TEACCH	Schopler (1972)	Strutturazione visiva e adattamento dell'ambiente al profilo autistico.
Approcci evolutivi	—	

Approccio	Autori / Anno	Caratteristiche principali
		Attenzione condivisa, imitazione, reciprocità sociale come base.
ESDM (Modello Denver)	Rogers e Dawson, anni 2000	Parent training + ABA + teoria dello sviluppo; da 12 mesi in poi.

Il prof sottolinea: non esiste un unico approccio corretto. La buona pratica educativa combina più metodi e si adatta alla persona.

Farmaci

Non esistono farmaci per l'autismo. I farmaci usati vengono prescritti su sintomi (es. ansia, agitazione) tratti da altre patologie. Devono sempre essere inseriti in un progetto terapeutico globale — non sono una soluzione in sé, e la decisione spetta al medico, non all'educatore.

Lavorare con le famiglie

Le famiglie non sono un contorno — sono risorse centrali. Il **parent training** è parte integrante dei migliori interventi.

Per un buon **patto educativo** con i genitori, i professionisti devono: - Sviluppare una relazione basata sulla **fiducia** (rispetto, coerenza, trasparenza, competenza) - Non colpevolizzare, non giudicare, non considerarli avversari - Evitare sentimenti di solidarietà/pietà — si lavora da professionisti - Considerare i bisogni globali della famiglia, non solo del figlio

E le famiglie, da parte loro, devono evitare scetticismo e pregiudizi sulla competenza dei professionisti.

Rischi e difficoltà per l'operatore

Difficoltà: - Selezionare informazioni valide tra miti e correnti diverse - Spiegare il disturbo a sé stessi e a terzi - Interagire con famiglie e colleghi - Motivarsi per certi tipi di intervento

Rischi: - **Inseguire terapie di moda o applicate in modo improvvisato** - Avere una visione a corto termine - Dipendere troppo da altri professionisti - Creare inconsapevolmente situazioni avversive - Escludere la famiglia dall'intervento - Fare assistenzialismo invece di lavorare su obiettivi

Risorse in Ticino

Il centro di competenza per l'autismo in Ticino è la **Fondazione ARES**: - Promuove la cultura sull'autismo tramite eventi e documentazione - Offre servizi specializzati (presa a carico, reinserimento professionale, supervisione) - Pubblica materiali di approfondimento e aggiornamento

Sito: fondazioneares.com

Fin qui ci siamo? Bene. Ora si cambia argomento — e si cambia anche la profondità del bisogno di sostegno. Il polyhandicap è un territorio diverso, più impattante, ma anche — come dice la prof — sorprendentemente arricchente.

Parte 2 — Polyhandicap

Definizione

Il **polyhandicap** è un deficit grave, ad espressioni multiple, che associa sempre: - Un **deficit fisico importante** - Un **deficit intellettuale severo o profondo**

Questa combinazione provoca una **restrizione estrema dell'autonomia** e delle possibilità di percezione, espressione e relazione.

È la **conseguenza di un danno cerebrale grave e incurabile** avvenuto precocemente (prima dei **3 anni**), che colpisce numerosi organi: sistema

neurologico, ortopedico, respiratorio, deglutizione, comunicazione. **Non è una patologia statica — evolve con l'età.**

Una presa a carico precoce e globale aiuta a limitarne le conseguenze e migliorare la qualità di vita della persona.

Le 5 dimensioni dell'AAIDD

Il deficit intellettivo viene analizzato attraverso le 5 dimensioni della definizione **AAIDD** (American Association on Intellectual and Developmental Disabilities):

Dimensione 1 — Funzionamento intellettuale

Deficit intellettivo profondo. Il livello di sviluppo è paragonabile a quello di un bebè sano di **6 mesi** (limite superiore: 12 mesi). Lo sviluppo si situa nel **periodo sensorio-motorio di Piaget**, nei sottostadi da 1 a 4.

Dimensione 2 — Funzionamento adattivo

- **Adattamento pratico** (cure, alimentazione): dipendenza totale
- **Adattamento concettuale**: comunicazione ristretta alla modalità non verbale

Dimensione 3 — Salute

Il danno cerebrale precoce porta a: - Polipatologie gravi ed evolutive - Multi-deficit sensoriali - **Epilessia frequente** — molte persone con polyhandicap hanno crisi epilettiche; dopo una crisi possono dormire 24 ore, e l'educatore deve adeguarsi - Tasso di mortalità elevato

I problemi si incatenano tra loro: il deficit motorio limita il movimento → il non movimento causa problemi posturali → i problemi posturali causano difficoltà respiratorie (i muco si accumulano nelle vie bronchiali). La prof fa l'esempio dell'anca: la testa del femore si struttura correttamente nell'acetabolo solo attraverso la verticalizzazione. Se la persona non sta mai in piedi, questa struttura non si forma — con conseguenze ortopediche permanenti. **Causa ed effetto si intrecciano in modo difficile da districare.**

Dimensione 4 — Interazione, partecipazione, ruoli sociali

- Interazioni inesistenti o estremamente povere
- Dipendenza totale per inserirsi nella comunità

Dimensione 5 — Contesto

- Necessità di un **partenariato intenso** con équipe pluridisciplinare
- **Esigenze etiche massime**

I sostegni

Con il polyhandicap, l'intensità dei **sostegni** (risorse e strategie per promuovere sviluppo e benessere) sarà tra **maggiore e intensiva** — i livelli più alti nella classificazione AAMR (2002).

Il dolore

Il dolore nel polyhandicap viene considerato in quattro forme: 1. **Dolori comuni** — influenza, mal di denti. Sì, anche questi, e non possono essere comunicati. 2.

Dolori causati dalla polipatologia 3. **Problemi di salute mentale** — anche un deficit intellettivo grave non protegge dalla depressione 4. **Dolori causati dalle cure quotidiane** (igiene, posizionamento, fisioterapia)

Un punto critico: i cambiamenti di comportamento spesso nascondono dolore fisico non comunicato. Come operatore devi osservare con attenzione e non dare nulla per scontato. Si conoscono casi di persone con polyhandicap che hanno vissuto con patologie dolorose per anni senza che nessuno se ne accorgesse.

Il comportamento adattivo

L'AAIDD definisce il **comportamento adattivo** come "l'insieme delle abilità concettuali, sociali e pratiche apprese per funzionare nella vita quotidiana". Nel polyhandicap i problemi investono tutti i livelli, anche i più basilari: alimentazione, idratazione, digestione, cura della pelle. La prevenzione è fondamentale.

Il problema della comunicazione nel polyhandicap

La comunicazione ha due livelli: - **Comprensione** (recettiva) - **Produzione** (espressiva)

La comprensione viene **sempre prima** della produzione — anche nello sviluppo tipico. L'errore più comune è pensare che chi non produce non comprenda. Non è così.

La prof porta un esempio toccante: una bambina diagnosticata con polyhandicap che a 7 anni, dopo che le è stato offerto un mezzo comunicativo alternativo, si è rivelata essere una bambina con capacità intellettive intatte, che leggeva autonomamente. Era stata classificata erroneamente per anni.

La comunicazione non verbale — lo sguardo, un piccolo gesto, una reazione — può essere il canale principale. Come operatore devi imparare a leggerla, senza dare per scontato né la comprensione né la non comprensione.

Si lavora su attività basilari — come suonare campane — proprio perché l'obiettivo è insegnare alla persona di essere **agente causale** nel suo ambiente: suono la campanella → c'è un effetto. Questa comprensione della causalità è il mattone su cui si costruisce tutta la comunicazione futura.

Lavorare con le famiglie nel polyhandicap

I genitori di una persona con polyhandicap hanno bisogno di sostegno nei momenti chiave del percorso: - All'annuncio della diagnosi - Per ottenere informazioni - Per accedere ai servizi - Per organizzarsi in famiglia - Per evitare il collocamento in istituto - Per la transizione alla vita adulta

Per i professionisti le difficoltà di lavoro sono reali e documentate: la tecnicità delle cure, il carico fisico ed emotivo, la natura eccezionale dei deficit. I sostegni richiesti riguardano mezzi logistici, definizione dei ruoli nell'équipe, partenariato con i genitori e sostegno psicologico.

Etica e qualità della vita

Il polyhandicap pone alcune delle questioni etiche più delicate del lavoro sociale. **Le persone con polyhandicap non possono esprimere verbalmente la propria volontà, e spesso non possono nemmeno segnalare disagio in modo riconoscibile.**

Questo richiede una cultura istituzionale attenta, supervisione costante e lavoro d'équipe — **mai da soli con questo tipo di utenza.**

La domanda etica centrale che l'operatore prima o poi si trova a fronteggiare: quando è il momento di mantenere la persona a domicilio con sostegni, e quando accompagnare verso l'istituzionalizzazione? Non esiste una risposta universale.

Domande di orientamento allo studio

Cosa si intende per analisi funzionale nel lavoro con persone con ASD e perché è più utile della sola diagnosi medica? L'analisi funzionale osserva e descrive come la persona funziona concretamente nelle diverse aree della vita — tenendo conto delle disabilità e difficoltà, del quadro complessivo delle capacità e delle potenzialità di sviluppo. È più utile della sola diagnosi medica perché ti dice cosa la persona sa fare in quel contesto specifico, a quell'ora del giorno, con quegli stimoli: "Mario alle 10 riesce a fare X ma non Y in quell'ambiente". Sapere che ha ASD di livello 2 non ti dice dove intervenire. L'analisi funzionale sì. È la base del PEI (Piano Educativo Individualizzato).

Quali sono i prerequisiti della comunicazione da sviluppare con le persone con ASD? I prerequisiti della comunicazione sono le fondamenta senza cui nessun sistema comunicativo — nemmeno il migliore tablet — può funzionare. Sono: percezione sensoriale (ascoltare, osservare espressioni e gesti), interazione sociale (trovare interesse per l'altro e per il mondo), imitazione (nei bambini con ASD è una difficoltà importante — va costruita intenzionalmente), gestualità (i gesti precedono il linguaggio: indicare, tendere le mani), attenzione condivisa (focalizzarsi sullo stesso oggetto/evento insieme a un'altra persona — senza questa non si costruisce niente sopra), intento comunicativo (voler comunicare — non è

scontato, va sviluppato), sviluppo cognitivo (riconoscimento di pattern, memoria, associazione di idee).

Come si gestiscono i comportamenti problema nelle persone con ASD? I

comportamenti problema non vanno soppressi — vanno compresi. L'approccio educativo li tratta come comunicazione: la persona sta cercando di esprimere qualcosa ma non ha strumenti adeguati. Il processo è: effettuare una valutazione funzionale per capire struttura e funzione del comportamento, poi insegnare un comportamento alternativo con la stessa funzione. Esempio dalla lezione: una ragazza con polyhandicap lanciava il piatto quando c'erano i pomodori — non era un problema di comportamento ma di comunicazione. La soluzione non era punirla ma trovare un canale per esprimere il rifiuto. Questo approccio vale per tutta l'utenza, non solo l'ASD.

Cos'è il polyhandicap? Quali sono le sue caratteristiche principali? Il

polyhandicap è un deficit grave, ad espressioni multiple, che associa sempre un deficit fisico importante a un deficit intellettivo severo o profondo. Questa combinazione causa una restrizione estrema dell'autonomia e delle possibilità di percezione, espressione e relazione. È la conseguenza di un danno cerebrale grave e incurabile avvenuto precocemente (prima dei 3 anni), che colpisce numerosi sistemi: neurologico, ortopedico, respiratorio, deglutizione, comunicazione. Non è una patologia statica — evolve con l'età. Il livello di sviluppo è paragonabile a quello di un bebè di circa 6 mesi (limite superiore 12 mesi), e i problemi si incatenano tra loro in modo complesso (es. deficit motorio → problemi posturali → difficoltà respiratorie).

Perché la comunicazione è così complessa nel polyhandicap e qual è l'errore più comune degli operatori? La comunicazione ha due livelli:

comprensione (recettiva) e produzione (espressiva). La comprensione viene sempre prima della produzione. L'errore più comune è pensare che chi non produce non comprenda — e questo è sbagliato. La prof porta l'esempio di una bambina diagnosticata con polyhandicap che a 7 anni, dopo che le è stato offerto un mezzo comunicativo alternativo, si è rivelata avere capacità intellettive intatte e saper leggere autonomamente. Era stata classificata erroneamente per anni. Come operatore devi imparare a leggere la comunicazione non verbale — lo sguardo, un

piccolo gesto, una reazione — senza dare per scontata né la comprensione né la non comprensione.

Quali sono i principali approcci e metodi nel lavoro con le persone con ASD? I principali approcci sono: ABA (Analisi Applicata del Comportamento, Skinner) — studia la relazione comportamento-ambiente in setting 1:1 con rinforzo positivo; Approcci Naturalistici — basati sull'ABA ma in contesti spontanei, seguono l'iniziativa del bambino; CBT (Terapia Cognitivo-Comportamentale) — lavora su pensieri, emozioni e comportamenti disfunzionali; TEACCH (Schopler, 1972) — strutturazione visiva e adattamento dell'ambiente; ESDM (Modello Denver) — parent training + ABA + teoria dello sviluppo, da 12 mesi in poi; CAA (Comunicazione Aumentativa e Alternativa) con sistemi come il PECS. Non esiste un unico approccio corretto — la buona pratica combina più metodi e si adatta alla persona.

Concetti chiave

Termine	Significato
ASD	Autism Spectrum Disorder — Disturbo dello Spettro Autistico
Analisi funzionale	Osservazione del funzionamento della persona nel suo contesto; base del lavoro educativo
PEI	Piano Educativo Individualizzato
Attenzione condivisa	Capacità di focalizzarsi insieme a un'altra persona sullo stesso oggetto/evento
CAA	Comunicazione Aumentativa e Alternativa
PECS	Picture Exchange Communication System — sistema CAA con carte-immagine
TEACCH	Programma di strutturazione visiva e adattamento ambientale (Schopler, 1972)
ABA	

Termine	Significato
	Applied Behavior Analysis — rinforzo dei comportamenti in setting 1:1
ESDM	Early Start Denver Model — intervento precoce (da 12 mesi) con parent training
Parent training	Lavoro diretto con i genitori per sviluppare competenze specifiche
Comportamento problema	Comportamento con funzione comunicativa; va compreso e sostituito, non soppresso
Valutazione funzionale	Strumento per capire struttura e funzione di un comportamento problema
Polyhandicap	Deficit grave multiplo: intellettivo profondo + fisico grave; conseguenza di danno cerebrale precoce
AAIDD	Organizzazione che fornisce la classificazione in 5 dimensioni del deficit intellettivo

Collegamenti

- **Lezione 08** — ASD Parte 1: criteri diagnostici DSM-5, spettro autistico, livelli 1-2-3, ipersensibilità sensoriale
- **Lezioni precedenti** — Concetto di funzionamento adattivo, sostegni (AAMR), ICF, deficit intellettivo
- **Da approfondire** — Approccio ABA in dettaglio; etica nel lavoro con persone non verbali; gestione del dolore nel polyhandicap
- **Risorse Ticino** — fondazioneares.com per aggiornamenti sull'autismo